LE CONSEIL DU MOIS

Arthrose : pourquoi bouger est l'un des meilleurs traitements pour tes articulations

Quand une articulation fait mal, le réflexe est souvent de la ménager. Pourtant, pour l'arthrose du genou ou de la hanche, l'exercice est l'un des traitements recommandés en première intention. Voici ce que disent les experts, et comment s'y prendre.



SANTÉ

POUR NOS CLIENTS ACTIFS · 4 MIN DE LECTURE

01

L'arthrose, ce n'est pas seulement de l'usure

L'arthrose est la maladie articulaire la plus fréquente. Elle touche surtout les genoux, les hanches, les mains et la colonne vertébrale. On la décrit souvent comme une usure du cartilage, mais c'est une vision incomplète. Il s'agit d'une atteinte de toute l'articulation : le cartilage, mais aussi l'os situé dessous, la membrane qui entoure l'articulation, les ligaments et les muscles autour.

Elle provoque des douleurs, une raideur, en particulier le matin ou après une période d'immobilité, et parfois une gêne dans les gestes du quotidien.

02

L'idée reçue à oublier

Pendant longtemps, on a pensé que le sport usait les articulations et qu'il fallait les ménager en cas d'arthrose. C'est faux. Le cartilage n'a pas de vaisseaux sanguins : il se nourrit grâce aux mouvements, qui font circuler le liquide articulaire, un peu comme une éponge qu'on presse et qu'on relâche. L'immobilité, au contraire, raidit l'articulation et affaiblit les muscles qui la protègent.

> **Le cartilage se nourrit du mouvement : l'immobilité est souvent la pire ennemie d'une articulation arthrosique.**

03

Ce que disent les experts

La Société internationale de recherche sur l'arthrose, l'OARSI, a publié en 2019 des recommandations pour le traitement de l'arthrose du genou, de la hanche et de l'arthrose touchant plusieurs articulations. Parmi les traitements dits essentiels, recommandés pour tous les patients, on trouve :

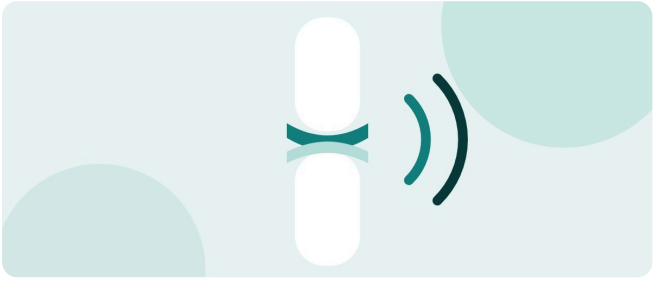
- L'exercice structuré, sous forme de renforcement musculaire, d'exercices cardiovasculaires ou de pratiques corps-esprit comme le tai-chi ou le yoga.
- L'éducation du patient sur sa maladie.
- La gestion du poids, lorsqu'elle est pertinente.

Une revue Cochrane de 2015, regroupant de nombreux essais sur l'arthrose du genou, a aussi montré que l'exercice réduisait la douleur et améliorait la fonction physique, avec des effets jugés modérés juste après le programme, comparables à ceux rapportés pour les anti-inflammatoires, puis plus faibles mais toujours présents deux à six mois plus tard.

04

Les exercices qui aident

- Le renforcement musculaire : renforcer les quadriceps, les fessiers et les ischio-jambiers soulage le genou et la hanche en absorbant une partie des contraintes. Par exemple, se lever d'une chaise, des ponts fessiers, des montées sur marche, de la presse à charge adaptée.
- Le cardio à faible impact : le vélo, la natation, l'aquagym, la marche, le vélo elliptique. Ils entretiennent le cœur sans traumatiser l'articulation.
- La mobilité : des mouvements doux dans toute l'amplitude possible, pour lutter contre la raideur.
- L'équilibre : des exercices sur une jambe, pour améliorer la stabilité et réduire le risque de chute.



Des muscles forts pour protéger l'articulation

05

La règle de la douleur acceptable

Avec l'arthrose, une légère douleur pendant l'exercice n'est pas forcément un signal d'arrêt. Les kinésithérapeutes utilisent souvent une règle simple :

- Une douleur jusqu'à 3 à 4 sur 10 pendant l'exercice est généralement acceptable.
- Elle doit revenir à son niveau habituel dans les 24 heures qui suivent.
- Si la douleur est plus forte, ou persiste le lendemain, on réduit la charge, l'amplitude ou le volume la fois suivante, sans tout arrêter.

> **Une douleur modérée qui revient à la normale en 24 heures est acceptable. Au-delà, on ajuste, on n'arrête pas.**

06

Le poids, un levier important

Pour l'arthrose du genou, le poids compte. Chaque pas fait supporter au genou une charge supérieure au poids du corps. Chez les personnes en surpoids, perdre quelques kilos peut soulager sensiblement les articulations portantes. L'alimentation et l'activité physique vont ensemble.

07

Les précautions

- L'arthrose doit être diagnostiquée par un médecin, qui peut aussi te prescrire de la kinésithérapie.
- En cas de poussée inflammatoire, avec une articulation gonflée, chaude et très douloureuse, on met l'articulation au repos relatif et on consulte.
- Les activités à fort impact, comme la course sur bitume ou les sauts répétés, se discutent au cas par cas. Elles ne sont pas forcément interdites, mais elles doivent être introduites progressivement.
- Un bon chaussant et des surfaces souples aident.

08

Comment je peux t'accompagner

Si tu as de l'arthrose, je peux adapter ton programme : choix des exercices, amplitudes, charges, progression. L'objectif est de renforcer les muscles qui protègent ton articulation, de garder la mobilité et de continuer à faire ce que tu aimes. Parle-m'en lors de ta prochaine séance, et n'hésite pas à partager les recommandations de ton médecin ou de ton kinésithérapeute.

À RETENIR

- L'arthrose touche toute l'articulation, pas seulement le cartilage.
- L'exercice est un traitement essentiel, recommandé par l'OARSI.
- Il réduit la douleur et améliore la fonction, avec des effets durables.
- Renforcement, cardio doux, mobilité et équilibre forment un bon programme.
- Une douleur modérée, qui revient à la normale en 24 heures, est acceptable.

SOURCES

- Bannuru R.R. et al., OARSI guidelines for the non-surgical management of knee, hip, and polyarticular osteoarthritis, Osteoarthritis and Cartilage (2019) : https://doi.org/10.1016/j.joca.2019.06.011
- Fransen M. et al., Exercise for osteoarthritis of the knee, Cochrane Database of Systematic Reviews (2015) : https://doi.org/10.1002/14651858.CD004376.pub3
- Organisation mondiale de la santé, Lignes directrices de l'OMS sur l'activité physique et la sédentarité, en un coup d'œil (2020) : https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240014886